• EBOOK PANDUAN

RPL Nakes 2026: Simulasi Asesmen, Pembinaan & Jalur Ukom Tanpa Salah Berkas

Simulasikan dari pemeriksaan eligibilitas sampai SK hasil asesmen, program pembinaan, dan jalur uji kompetensi ulang sesuai Kepdirjen Dikti 106/B/KPT/2026.



"Belajar. Praktik. Naik Level."

Diterbitkan oleh **Naik Level Id**
Panduan belajar praktis & aplikatif

B A B 1

Mengapa RPL Nakes 2026 Menjadi Jalur Kritis

Kalau kamu sedang membaca ebook ini, kemungkinan besar kamu sedang menghadapi satu situasi yang tidak nyaman: ada mahasiswa kesehatan yang sudah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran—kuliah, praktikum, skripsi, KKN—tetapi masih belum lulus uji kompetensi. Statusnya menggantung. Masa studinya terus bertambah. Program studi dan institusi ikut terkena getahnya.

Nah, terbitnya Kepdirjen Dikti Nomor 106/B/KPT/2026 memberikan jalan keluar yang sah secara akademik dan administratif melalui **skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) khusus untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes)**. Tapi jalan keluar ini bukan berarti pintu tol bebas hambatan. Justru karena menyangkut kelulusan, penjaminan mutu, dan akuntabilitas institusi, **jalur ini kritis**: satu keputusan keliru dalam memilih peserta, menilai bukti, atau menerbitkan surat keputusan dapat menunda kelulusan dan memicu pertanyaan dari LLDikti, asosiasi profesi, atau bahkan pengawas eksternal.

Konteks kebijakan: bukan RPL biasa

Kepdirjen 106/B/KPT/2026 lahir dari kebutuhan mendesak untuk mempercepat ketersediaan tenaga kesehatan di Indonesia. Skema ini menyasar mahasiswa yang **telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran pada program studi kesehatan**, tetapi belum lulus uji kompetensi sebagai syarat kelulusan. Secara teknis, mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran akademik, tetapi masih terkendala pada uji yang

bersifat profesi.

Ini berbeda dari RPL umum yang biasanya digunakan untuk mengakui pembelajaran lampau dari pengalaman kerja, pelatihan, atau pendidikan nonformal. Skema khusus ini tetap mengacu pada **juknis RPL umum**—terutama soal prinsip asesmen, bukti capaian pembelajaran, kualifikasi asesor, dan pelaporan—tetapi dengan penyesuaian objek: yang dinilai bukan pengalaman kerja, melainkan **bukti capaian pembelajaran dari riwayat studi dan kebutuhan pembinaan untuk lulus uji kompetensi**.

> ⚠ **Penting: RPL khusus nakes bukan untuk mahasiswa yang masih aktif menempuh SKS atau yang gagal ukom karena belum pernah mengikuti pembelajaran. Sasaran utamanya adalah mahasiswa yang sudah selesai tahap akademik tetapi belum lulus ukom—bukan jalur pintas menggantikan uji kompetensi.**

Mengapa ini menjadi jalur kritis bagi institusi?

Bagi perguruan tinggi kesehatan, kesalahan dalam menerapkan skema ini bukan sekadar masalah administratif. Beberapa risiko yang umum terjadi:

- **Salah memilih peserta**: memasukkan mahasiswa yang sebenarnya belum selesai pembelajaran atau belum memenuhi syarat administratif, sehingga keputusan RPL-nya cacat.
- **Bukti capaian tidak tertelusur**: transkrip, riwayat praktik, catatan bimbingan, dan hasil ukom sebelumnya tersebar di prodi, akademik, dan unit mutu, sehingga asesor kesulitan memvalidasi.
- **Asesmen tidak konsisten**: asesor akademik dan praktisi bisa berbeda persepsi karena belum ada rubrik pemeriksaan administratif yang

seragam.

- **SK dan program pembinaan tidak terdokumentasi**: arahan informal “nanti dibina ya” tidak cukup; harus ada rencana, penugasan tim, dan catatan tindak lanjut.

Jika institusi tidak siap saat diminta menjelaskan dasar keputusan akademiknya, dampaknya bisa panjang: status mahasiswa tertunda, akreditasi dipertanyakan, dan kepercayaan pemangku kepentingan menurun.

Langkah praktik: mulai dari pemetaan awal

Supaya tidak tersesat, lakukan tiga langkah konkret ini di minggu pertama:

1. **Identifikasi daftar calon peserta**
   Minta kaprodi mengeluarkan daftar mahasiswa dengan status: seluruh SKS selesai, tetapi belum lulus uji kompetensi. Pastikan setiap nama punya catatan tanggal selesai pembelajaran, jumlah percobaan ukom, dan alasan ketidaklulusan terakhir.

2. **Bentuk tim kecil lintas unit**
   Libatkan minimal tiga peran: kaprodi (pemilik data akademik), pengelola RPL (paham juknis umum), dan satu perwakilan unit penjaminan mutu. Tugas awal tim ini: membaca Kepdirjen 106/B/KPT/2026 dan juknis RPL umum secara paralel, lalu menandai pasal atau butir yang mengatur perbedaan skema khusus dan umum.

3. **Buat tabel pembeda sederhana**
   Buat dua kolom: “RPL Umum” dan “RPL Khusus Nakes”. Isi baris untuk: sumber bukti utama, kriteria peserta, fokus asesmen, kebutuhan asesor, dan luaran keputusan. Ini akan menjadi peta keputusan awal sebelum masuk ke kasus nyata.

Contoh nyata: Mahasiswa A dari prodi S1 Keperawatan telah lulus seluruh 148 SKS pada Agustus 2025, IPK 3,15, tetapi sudah tiga kali gagal ukom. Ia tidak sedang bekerja sebagai perawat. Apakah masuk RPL khusus? **Ya**—karena ia sudah selesai pembelajaran, bukan karena pengalaman kerja. Fokus asesmennya adalah pemetaan capaian dari transkrip, riwayat praktik klinik, dan identifikasi kompetensi lemah untuk pembinaan, bukan penilaian pengalaman profesional.

⛔ **Waspada: Jangan mencampurkan mahasiswa yang gagal ukom karena belum pernah mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan yang sudah selesai. Skema khusus hanya untuk yang kedua. Jika ragu, konsultasikan dulu ke perguruan tinggi pendamping atau LLDikti sebelum menerbitkan keputusan apa pun.**

Dengan memahami konteks, sasaran, dan titik kritis sejak awal, kamu bisa menghindari perbaikan dokumen di tengah jalan—yang biasanya justru lebih lama dan lebih menyakitkan.

INTI BAB: RPL Nakes 2026 adalah jalur khusus untuk mahasiswa kesehatan yang sudah selesai pembelajaran tetapi belum lulus uji kompetensi, tetap mengacu pada prinsip juknis RPL umum. Langkah awal yang harus dilakukan institusi adalah memetakan peserta secara tepat, membentuk tim lintas unit, dan membedakan skema khusus dari RPL umum sebelum menyentuh keputusan akademik.

B A B 2

Peta Peran dan Batas Kewenangan Institusi

Masalah klasik di lapangan bukan karena orangnya tidak kompeten, melainkan karena tidak ada satu peta yang disepakati bersama. Bukti capaian belajar tersebar di prodi, riwayat studi di bagian akademik, catatan pembinaan di dosen wali, sementara keputusan akhir harus ditandatangani pimpinan. Kalau tidak ada pembagian peran yang eksplisit, setiap unit akan menganggap tugasnya hanya bagian kecil, dan tidak ada yang merasa bertanggung jawab memastikan seluruh alur konsisten.

Di bab ini kamu akan belajar memetakan siapa melakukan apa, dokumen apa yang jadi tanggung jawabnya, dan di titik mana kewenangan satu pihak berhenti lalu berpindah ke pihak lain. Fokusnya pada skema khusus RPL untuk mahasiswa nakes yang sudah selesai pembelajaran tetapi belum lulus uji kompetensi.

Langkah Praktik Memetakan Peran

1. **Identifikasi aktor kunci.** Dalam satu siklus RPL khusus nakes, setidaknya ada tujuh peran yang tidak boleh tumpang tindih: pimpinan perguruan tinggi, dekan, kaprodi, pengelola RPL, asesor, unit penjaminan mutu, dan admin pelaporan. Perguruan tinggi pendamping berperan sebagai konsultan bila kasusnya ambigu atau butuh pembanding eksternal.
2. **Tetapkan batas kewenangan setiap peran.**
    - **Pimpinan PT** menerbitkan SK hasil asesmen, SK penugasan tim,

dan keputusan pembinaan formal.

- **Dekan** memastikan kebijakan fakultas selaras dengan juknis RPL dan mengesahkan rekomendasi kaprodi.
- **Kaprodi** memverifikasi kelengkapan dokumen awal mahasiswa dan mengusulkan calon peserta RPL.
- **Pengelola RPL** mengelola alur administrasi, menyusun jadwal asesmen, dan menjaga konsistensi berkas.
- **Asesor** menilai capaian pembelajaran dan kebutuhan penguatan, baik dari sisi akademik maupun praktisi.
- **Unit mutu** memeriksa kesesuaian proses dengan standar penjaminan mutu, termasuk rubrik penilaian dan bukti pembinaan.
- **Admin pelaporan** merekap hasil, mengunggah data ke sistem, dan memastikan pelaporan tidak terlambat.
- **PT pendamping** memberikan second opinion ketika ada perbedaan tafsir antara asesor atau keraguan soal kelayakan skema.

3. **Buat alur dokumen sederhana** untuk menghindari bolak-balik. Misalnya: berkas mahasiswa → kaprodi cek kelengkapan → pengelola RPL input data → asesor nilai → unit mutu review kesesuaian → dekan rekomendasi → pimpinan PT terbitkan SK → admin pelaporan unggah laporan. Setiap perpindahan harus meninggalkan jejak dokumen, bukan hanya lisan.

Catatan: Skema RPL umum untuk pengakuan pengalaman kerja berbeda dengan skema khusus mahasiswa nakes yang belum lulus uji kompetensi. Pada skema khusus, fokusnya bukan menghitung angka kredit pengalaman, melainkan memetakan capaian pembelajaran yang sudah diperoleh selama kuliah dan praktik, lalu mengaitkannya dengan program penguatan sebelum uji ulang. Jangan campur kedua alur ini karena dasar hukum dan bukti yang dipakai berbeda.

4. **Uji peta peran dengan satu kasus simulasi.** Ambil contoh mahasiswa prodi D3 Keperawatan, sudah selesai seluruh SKS dan praktik klinik, tetapi dua kali belum lulus uji kompetensi. Jalankan alurnya: siapa yang pertama kali mengidentifikasi kasus? Kaprodi. Siapa yang memverifikasi riwayat studi? Bagian akademik dibantu admin pelaporan. Siapa yang menilai capaian? Dua asesor—satu akademik, satu praktisi. Siapa yang memutuskan mahasiswa perlu pembinaan? Pimpinan PT berdasarkan rekomendasi asesor dan dekan. Jika di salah satu titik tidak ada nama yang jelas, berarti peta peranmu masih bolong.

⚠ Penting: Jangan biarkan kaprodi merangkap sebagai asesor untuk mahasiswa dari prodinya sendiri. Ini menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan objektivitas asesmen. Tetap gunakan asesor independen atau minimal asesor dari prodi lain, dan libatkan praktisi bila memungkinkan.

5. **Evaluasi peta peran secara berkala.** Setiap kali ada kasus baru, catat di mana terjadi penundaan atau kesalahan. Bisa jadi karena satu peran memegang terlalu banyak kendali, atau ada dokumen yang tidak jelas

penanggung jawabnya. Perbaiki alurnya, lalu sosialisasikan ulang ke semua unit.

Dengan peta peran yang tegas, institusi tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi “pasti ada yang mengurus”. Setiap orang tahu kapan harus bertindak, dokumen apa yang harus disiapkan, dan kepada siapa harus berkoordinasi. Ini fondasi sebelum masuk ke simulasi kasus lengkap di bab berikutnya.

INTI BAB: Peta peran yang jelas—siapa menyiapkan, memverifikasi, menilai, menyetujui, dan melaporkan—mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan setiap keputusan RPL khusus nakes punya jejak dokumen yang dapat ditelusuri.

B A B 3

Simulasi Pemeriksaan Eligibilitas Mahasiswa

Pemeriksaan eligibilitas adalah gerbang pertama sebelum seorang mahasiswa masuk ke skema RPL, pembinaan, atau uji kompetensi ulang. Kalau salah memilih peserta, seluruh proses di belakangnya bisa bermasalah: asesmen tidak relevan, SK tidak sah, dan pelaporan jadi bahan pertanyaan. Di bab ini, kita akan melakukan simulasi pemeriksaan dengan satu kasus nyata supaya tim kamu punya urutan kerja yang jelas.

Mulai dari mengumpulkan dokumen dasar sampai memutuskan jalur, ikuti langkah-langkah berikut. Jangan lompat, karena setiap langkah saling mengunci.

Langkah 1: Kumpulkan Dokumen Dasar Mahasiswa

Minta bagian akademik atau program studi menyiapkan berkas berikut untuk setiap calon peserta:

- KHS/transkrip nilai terbaru
- Surat keterangan telah menyelesaikan seluruh tahap pembelajaran (teori, praktik, dan/atau klinik)
- Riwayat uji kompetensi (berapa kali mengikuti, kapan, dan hasilnya)
- Surat keputusan status mahasiswa (aktif, non-aktif, atau cuti)
- Dokumen pendukung lain seperti sertifikat pelatihan, portofolio praktik, atau bukti bimbingan

Cek kelengkapan fisik dan digital. Sering kali riwayat uji kompetensi tersebar di unit kemahasiswaan, sementara transkrip di bagian akademik. Kalau ada

satu saja dokumen hilang, tunda dulu keputusan eligibilitas sampai lengkap — jangan menebak.

Langkah 2: Verifikasi Status Pembelajaran dan Masa Studi

Ini titik paling rawan. Kamu harus memastikan dua hal:

1. **Apakah mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran?** Artinya, semua SKS teori dan praktik sudah tuntas, tidak ada mata kuliah tersisa, dan program studi sudah menerbitkan surat keterangan selesai pembelajaran. Kalau masih ada satu mata kuliah mengulang, dia belum layak masuk skema khusus RPL untuk mahasiswa yang “telah selesai pembelajaran tetapi belum lulus uji kompetensi”. Dia mungkin lebih cocok ke pembinaan akademik biasa.
2. **Bagaimana status masa studinya?** Untuk skema khusus RPL Nakes, biasanya mahasiswa sudah melampaui batas masa studi normal, tetapi masih dalam rentang yang diizinkan oleh peraturan. Kalau masa studinya masih normal, jangan paksakan masuk skema khusus — kecuali ada kebijakan internal yang mengatur lain. Kalau sudah lewat batas maksimal, perlu konsultasi ke perguruan tinggi pendamping atau LLDIKTI.

Langkah 3: Telusuri Riwayat Uji Kompetensi

Mahasiswa yang masuk skema khusus RPL umumnya sudah pernah menempuh uji kompetensi tetapi belum lulus. Kamu perlu mencatat:

- Berapa kali ikut ujian
- Tanggal dan periode ujian

- Skor atau hasil tiap percobaan
- Alasan ketidaklulusan (jika ada umpan balik)

Riwayat ini penting untuk dua hal: pertama, memastikan mahasiswa memang masuk kategori “belum lulus uji kompetensi” (bukan belum pernah ikut sama sekali), dan kedua, menjadi dasar menyusun program pembinaan yang tepat. Kalau mahasiswa belum pernah ikut ukom, dia mungkin lebih cocok ke pembinaan persiapan ukom biasa, bukan RPL.

Langkah 4: Petakan Bukti Capaian Pembelajaran

Sekarang lihat transkrip dan bukti praktik. Tujuanmu bukan menilai kompetensi, tapi memastikan ada cukup bukti awal bahwa mahasiswa pernah menempuh dan menyelesaikan seluruh capaian pembelajaran. Perhatikan:

- Apakah ada mata kuliah inti yang nilainya sangat rendah atau tidak lulus berulang?
- Apakah ada bukti praktik klinik/kerja lapangan yang sah (logbook, penilaian pembimbing)?
- Apakah ada gap antara kurikulum yang ditempuh dengan standar kompetensi terbaru? Ini akan menentukan kebutuhan penguatan.

Hasil pemetaan ini akan menjadi masukan awal bagi asesor, bukan pengganti asesmen.

> **⚠ Penting: Jangan mencampur pemeriksaan administratif dengan penilaian kompetensi. Pemeriksaan eligibilitas hanya menentukan “layak atau tidak layak masuk skema”, bukan menilai seberapa kompeten mahasiswa. Penilaian kompetensi adalah tugas asesor setelah eligibilitas dinyatakan lolos.**

Langkah 5: Putuskan Jalur

Setelah empat langkah di atas selesai, kamu bisa mengambil keputusan awal. Gunakan panduan berikut:

- **Masuk skema RPL khusus** jika: mahasiswa telah menyelesaikan seluruh pembelajaran, melampaui masa studi, memiliki riwayat uji kompetensi belum lulus, dan dokumen lengkap.
- **Masuk RPL umum** jika: mahasiswa memiliki pengalaman kerja atau pembelajaran non-formal yang relevan, tetapi belum tentu selesai pembelajaran formal.
- **Masuk pembinaan persiapan ukom** jika: mahasiswa masih dalam masa studi normal, belum pernah atau baru sekali ikut ukom, dan belum ada kebutuhan pengakuan pembelajaran lampau.
- **Konsultasikan ke perguruan tinggi pendamping** jika: ada keraguan pada status masa studi, dokumen tidak lengkap, atau kasus di luar kebijakan yang sudah ditetapkan.

Simulasi Kasus: Mahasiswa Sari

Sari, mahasiswi Prodi Kebidanan angkatan 2018. Ia telah menyelesaikan seluruh SKS teori dan praktik klinik pada Agustus 2024. Ia sudah tiga kali mengikuti uji kompetensi (Oktober 2024, April 2025, Agustus 2025) dan ketiganya belum lulus pada komponen tertentu. Masa studi normal 4 tahun, tetapi Sari sudah melewati batas karena perpanjangan studi. Program studi menerbitkan surat keterangan selesai pembelajaran, dan transkrip lengkap.

Pemeriksaan eligibilitas untuk Sari:

1. Dokumen dasar: lengkap — transkrip, surat selesai pembelajaran, riwayat ukom tiga kali, SK perpanjangan masa studi.

2. Status pembelajaran: selesai, tidak ada mata kuliah tersisa.
3. Masa studi: melampaui batas normal tetapi masih dalam rentang perpanjangan yang diizinkan.
4. Riwayat ukom: sudah tiga kali, belum lulus.
5. Bukti capaian: transkrip menunjukkan semua mata kuliah inti lulus, logbook praktik lengkap, ada catatan kelemahan pada asuhan kebidanan komunitas.

Keputusan: Sari lolos eligibilitas untuk masuk skema RPL khusus. Langkah berikutnya adalah pemetaan capaian, penunjukan asesor, dan asesmen. Jangan langsung menerbitkan SK hasil asesmen sebelum asesmen dilakukan.

Checklist Verifikasi Cepat:

- ☐ Dokumen akademik lengkap dan sah?
- ☐ Status mahasiswa jelas (aktif/non-aktif dengan alasan)?
- ☐ Seluruh pembelajaran sudah selesai?
- ☐ Riwayat uji kompetensi terdokumentasi?
- ☐ Masa studi sesuai kategori skema?
- ☐ Bukti capaian cukup untuk dilanjutkan ke asesmen?

Simulasi ini bisa kamu ulangi untuk setiap calon peserta. Pastikan semua anggota tim menggunakan urutan dan checklist yang sama supaya tidak ada perbedaan keputusan antar program studi.

INTI BAB: Pemeriksaan eligibilitas menentukan layak tidaknya mahasiswa masuk skema RPL khusus, dan harus dilakukan dengan urutan dokumen, status studi, riwayat ukom, serta pemetaan bukti sebelum menyerahkan ke asesor.

B A B 5

Simulasi Kerja Asesor RPL

Sebelum kamu menilai kasus nyata, latih dulu tim asesor dengan satu kasus simulasi. Tujuannya bukan menghafal prosedur, tapi membiasakan alur keputusan yang bisa ditelusuri—karena saat nanti ada pertanyaan “kenapa mahasiswa ini disetujui atau ditolak,” jawaban kamu harus merujuk pada bukti, bukan kesan.

Simulasi ini juga memaksa tim untuk memisahkan peran akademik dan praktisi sejak awal. Kalau tidak dilatih, asesor akademik cenderung fokus pada transkrip, sementara praktisi fokus pada keterampilan klinis. Keduanya penting, tapi harus bertemu di titik yang sama: capaian pembelajaran dan kebutuhan pembinaan.

Langkah 1: Bentuk pasangan asesor dan peta tanggung jawab

Setiap kasus RPL khusus nakes yang belum lulus ukom minimal ditangani oleh dua asesor:

- **Asesor akademik** memeriksa kesesuaian kurikulum, transkrip, capaian pembelajaran mata kuliah, dan relevansi riwayat studi dengan profil lulusan.
- **Asesor praktisi** menilai bukti praktik klinis, logbook, portofolio keterampilan, dan kesiapan menghadapi uji kompetensi ulang.
- **Admin pengelola RPL** memverifikasi kelengkapan berkas, memastikan dokumen terarsip, dan mencatat setiap keputusan dalam sistem.
- **Pimpinan / ketua asesor** menetapkan keputusan akhir bila terjadi perbedaan hasil, lalu menerbitkan SK.

Jangan biarkan asesor bekerja sendirian tanpa koordinasi. Simulasikan

pembagian ini dengan satu kasus fiktif dulu.

Langkah 2: Jalankan pemeriksaan dokumen awal dengan decision tree singkat

Buat alur pertanyaan sederhana di depan tim:

1. Apakah mahasiswa telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran (teori dan praktik) di program studi?
2. Apakah mahasiswa belum lulus uji kompetensi dan masih berstatus aktif?
3. Apakah tersedia bukti transkrip, surat keterangan lulus teori, logbook praktik, dan dokumen pembinaan internal?
4. Apakah program studi memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan pembinaan lanjutan?

Jika jawaban 1–3 “ya” dan 4 “ya”, mahasiswa masuk skema RPL khusus. Jika ada salah satu tidak terpenuhi, kembalikan ke RPL umum atau konsultasikan dengan perguruan tinggi pendamping.

Contoh kasus simulasi: *Mahasiswa A, program studi D3 Keperawatan, telah menyelesaikan 110 SKS teori dan praktik, IPK 2,75, tetapi belum lulus ukom sebanyak 2 kali. Ia memiliki transkrip lengkap, surat keterangan selesai teori, logbook praktik klinik 600 jam, dan bukti pembinaan internal dari kaprodi.* Tim asesor langsung menyimpulkan: masuk skema khusus.

> 💡 **Tips: Latih asesor menuliskan alasan keputusan dengan merujuk bukti spesifik, bukan kesan. Kalimat “mahasiswa kurang percaya diri” harus diubah menjadi “pada simulasi resusitasi, mahasiswa melakukan kompresi dengan kedalaman tidak sesuai standar (terlalu dangkal) berdasarkan video praktik menit 3:20.” Dengan begitu, keputusan bisa diuji dan dipertahankan.**

Langkah 3: Gunakan matriks bukti untuk asesmen

Siapkan tabel sederhana dengan kolom: **Elemen Capaian | Bukti Dokumen | Kualitas Bukti | Catatan Asesor | Kebutuhan Pembinaan**.

Latih kedua asesor mengisi matriks ini untuk kasus simulasi. Misalnya:

- **Elemen Capaian:** Asuhan keperawatan dasar
  Bukti Dokumen: Transkrip nilai B, logbook praktik 200 jam, penilaian klinik
  Kualitas Bukti: Transkrip dan logbook lengkap, penilaian klinik ada catatan pembimbing
  Catatan Asesor: Nilai keterampilan kegawatdaruratan hanya C
  Kebutuhan Pembinaan: Simulasi kegawatdaruratan 2 sesi, pendampingan pembimbing klinik

Dengan matriks ini, asesor akademik dan praktisi melihat bukti yang sama, sehingga perbedaan fokus bisa dikelola sejak awal.

Langkah 4: Catat alasan keputusan di berita acara

Setiap asesor menuliskan hasil penilaian dan alasan spesifik dalam berita acara. Format minimalnya:

- Hasil penilaian: lulus / lulus dengan catatan / perlu pembinaan / belum

memenuhi

- Alasan keputusan: merujuk pada bukti, misalnya *“Mahasiswa A lulus asesmen untuk mata kuliah X dengan catatan memerlukan pembinaan keterampilan Y, berdasarkan transkrip nilai B, logbook praktik 120 jam, dan hasil simulasi praktik mandiri tanggal DD/MM.”*
- Rekomendasi pembinaan: jenis penguatan, jadwal, dan penanggung jawab
- Tanda tangan kedua asesor

Dokumen ini menjadi inti pertanggungjawaban akademik.

Langkah 5: Kendalikan perbedaan hasil asesor akademik dan praktisi

Perbedaan itu wajar, tapi harus dikelola. Simulasikan skenario berikut: asesor akademik menilai mahasiswa “cukup” karena transkrip bagus, sedangkan asesor praktisi menilai “perlu pembinaan” karena logbook menunjukkan jam praktik banyak tapi keterampilan kritis lemah.

Alur kalibrasinya:

1. Bahas bukti yang sama di hadapan ketua asesor.
2. Cek rubrik pemeriksaan administratif dan matriks bukti.
3. Jika asesor praktisi menemukan bukti keterampilan yang tidak didukung transkrip, asesor akademik wajib meninjau ulang.
4. Bila perbedaan tetap, ketua asesor menetapkan keputusan berdasarkan bukti dominan dan mencatat risiko pembinaan tambahan.

Dengan latihan ini, tim tidak akan kebingungan saat menghadapi kasus nyata.

Checklist sebelum terbit SK hasil asesmen:

[ ] Berkas identitas dan riwayat studi lengkap?
[ ] Berita acara asesmen ditandatangani kedua asesor?
[ ] Alasan keputusan merujuk bukti spesifik?
[ ] Rencana pembinaan mencantumkan jadwal dan penanggung jawab?
[ ] Draft SK sudah diverifikasi unit penjaminan mutu?

Latihan simulasi ini sebaiknya diulang minimal dua kali: satu kasus dengan keputusan “lulus dengan pembinaan ringan”, satu kasus dengan “perlu pembinaan intensif”. Setelah selesai, tutup siklus dengan memastikan semua arsip, berita acara, rencana pembinaan, dan draft SK tersimpan dalam satu folder yang sama dan bisa diakses pimpinan saat dibutuhkan.

INTI BAB: Simulasi kerja asesor RPL melatih tim memisahkan peran akademik dan praktisi, mencatat alasan keputusan berbasis bukti, serta mengendalikan perbedaan hasil melalui kalibrasi dan matriks bukti sebelum SK diterbitkan.

B A B 6

SK, Berita Acara dan Keputusan Pembinaan

Setelah asesmen selesai, saatnya mengubah hasil diskusi menjadi dokumen resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa SK, Berita Acara, dan Keputusan Pembinaan yang tertib, keputusan akademik RPL hanya dianggap angin lalu—dan saat ada audit, kamu akan kesulitan menjelaskan dasar keputusanmu. Bab ini fokus pada urutan dokumen, cara mengesahkan, dan mengarsipkan bukti.

Urutan dokumen yang harus kamu siapkan (jangan loncat-loncat):

1. **Berita Acara Asesmen (BAA) per mahasiswa.** Ini dokumen paling dasar. Setiap mahasiswa yang selesai asesmen harus punya BAA yang memuat: identitas mahasiswa, tanggal asesmen, nama asesor, ringkasan hasil per kompetensi, dan rekomendasi (RPL terpenuhi penuh, terpenuhi sebagian, atau perlu pembinaan). Pastikan BAA ditandatangani asesor dan mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak hadir, catat sebagai ketidakhadiran dan jadwalkan ulang—jangan biarkan asesmen tanpa jejak.
2. **Rekap hasil asesmen per program studi.** Setelah semua BAA terkumpul, susun tabel rekap: nama mahasiswa, NIM, status RPL, catatan khusus. Ini memudahkan pimpinan melihat gambaran besar. Rekap ini menjadi lampiran SK penetapan hasil RPL.
3. **SK Penetapan Hasil RPL.** Di sinilah keputusan resmi keluar. Pimpinan perguruan tinggi (rektor/direktur) menerbitkan SK yang berisi daftar mahasiswa yang RPL-nya diterima penuh, diterima sebagian dengan

syarat pembinaan, atau ditolak. Untuk yang diterima sebagian, tuliskan secara eksplisit kewajiban mengikuti pembinaan dan target uji kompetensi ulang. Jangan hanya menulis “diterima” tanpa rincian.

4. **SK Penugasan Tim Pembinaan.** Jika ada mahasiswa yang butuh pembinaan, terbitkan SK yang menunjuk koordinator, dosen pembimbing, dan praktisi/CI (clinical instructor). SK ini penting agar tim pembinaan punya dasar legal untuk melibatkan praktisi dari luar kampus —dan agar waktu mereka dihitung sebagai beban kerja.

5. **Keputusan Pembinaan.** Dokumen ini berisi rencana program penguatan: materi, jadwal, metode, target capaian, dan durasi. Misalnya: “Pembinaan keterampilan klinis dasar selama 6 minggu, 3x pertemuan per minggu, dengan simulasi dan OSCE mini.” Keputusan ini bisa ditandatangani dekan atau kaprodi, tetapi harus merujuk pada SK Penetapan Hasil RPL.

6. **Berita Acara Pembinaan dan Uji Kompetensi Ulang.** Setelah pembinaan berjalan, catat setiap sesi: kehadiran, materi, evaluasi. Saat mahasiswa mengikuti ukom ulang, buat berita acara hasilnya. Ini bukti bahwa pembinaan bukan sekadar formalitas.

7. **Arsip digital dan fisik.** Simpan seluruh dokumen dalam folder terstruktur per mahasiswa atau per angkatan. Beri nama file konsisten, misalnya: `BAA_2026_NIM_NAMA.pdf`, `SK_Hasil_RPL_2026.pdf`. Simpan salinan fisik di bagian akademik, dan pastikan unit penjaminan mutu punya akses digital.

Contoh nyata: Mahasiswa keperawatan “Sari” belum lulus ukom. Hasil asesmen menunjukkan teori 78% tapi keterampilan klinis 55%. BAA merekomendasikan pembinaan praktik. SK Penetapan Hasil RPL menyatakan

Sari diterima sebagian dengan syarat mengikuti pembinaan. SK Penugasan Tim menunjuk dosen pembimbing dan CI rumah sakit. Keputusan Pembinaan memuat jadwal simulasi pasien 3x seminggu selama 8 minggu. Setelah selesai, Sari mengikuti ukom ulang dan

B A B 7

Merancang Program Pembinaan Menuju Uji Kompetensi

Asesmen sudah selesai, hasilnya sudah keluar. Tapi jangan buru-buru bilang ke mahasiswa, “Ya sudah, belajar lagi ya, nanti ujian ulang.” Kalau hanya begitu, status mahasiswa bisa menggantung, program studi tidak punya jejak pembinaan, dan saat ada pertanyaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau asesor eksternal, kita tidak bisa menunjukkan dasar keputusan akademiknya.

Nah, di bab ini kita ubah hasil asesmen menjadi **peta gap**, lalu menyusun rencana penguatan yang jelas: siapa penanggung jawabnya, kapan jadwalnya, apa bukti penyelesaiannya. Tujuannya satu: mahasiswa siap mengikuti uji kompetensi ulang, dan institusi punya arsip pembinaan yang bisa ditelusuri.

Langkah 1: Buat Peta Gap dari Hasil Asesmen

Ambil berita acara asesmen, lalu petakan tiap kompetensi yang dinilai. Pisahkan yang **sudah memenuhi standar** dan yang **belum memenuhi standar**. Untuk yang belum, tuliskan bukti asesmennya apa (misal: nilai praktik di transkrip, hasil uji simulasi, catatan asesor), apa gap-nya, dan tingkat prioritasnya.

Contoh sederhana untuk mahasiswa D3 Keperawatan:

- Kompetensi: Asuhan keperawatan kegawatdaruratan
- Bukti asesmen: Hasil simulasi kode biru, nilai 58 dari skala 100, asesor mencatat mahasiswa ragu saat melakukan resusitasi awal
- Gap: Belum mampu melakukan prioritas tindakan dan komunikasi tim

dalam kondisi gawat darurat

- Prioritas: Tinggi, karena menjadi kompetensi inti yang diujikan ulang

Langkah ini bisa dilakukan manual di spreadsheet atau tabel sederhana. Yang penting semua kompetensi yang menjadi syarat kelulusan terpetakan, tidak ada yang terlewat.

> ⚠ **Penting: Jangan mencampur peta gap RPL umum dengan skema khusus mahasiswa nakes yang belum lulus uji kompetensi. Pada skema khusus ini, peta gap harus fokus pada kompetensi yang diuji oleh uji kompetensi nasional, bukan sekadar pengakuan pengalaman kerja atau pembelajaran lampau.**

Langkah 2: Tentukan Bentuk Pembinaan

Setiap gap punya karakter berbeda, jadi bentuk penguatannya juga harus berbeda. Jangan samakan semua mahasiswa dengan "belajar mandiri." Beberapa contoh:

- Gap di **keterampilan klinis**: jadwalkan praktik ulang di laboratorium atau klinik dengan supervisi asesor praktisi.
- Gap di **pengetahuan terapan**: berikan tutorial terstruktur dengan studi kasus dan kuis formatif.
- Gap di **sikap profesional dan komunikasi**: gunakan role-play, observasi langsung, dan umpan balik terstruktur.

Tuliskan bentuk pembinaan untuk setiap gap di kolom rencana aksi. Misalnya untuk gap kegawatdaruratan di atas: "Simulasi kode biru 3 kali, 2 kali dengan umpan balik asesor, 1 kali penilaian formatif."

Langkah 3: Tetapkan Penanggung Jawab dan Jadwal

Program penguatan tanpa penanggung jawab hanya akan menjadi wacana. Untuk setiap rencana aksi, tentukan:

- Siapa penanggung jawab utama? Bisa kaprodi, asesor akademik, asesor praktisi, atau pembimbing klinik.
- Siapa pendukung? Misalnya laboran, admin prodi.
- Kapan mulai dan selesai? Buat jadwal mingguan yang realistis, jangan terlalu padat tapi juga jangan terlalu longgar.

Contoh rencana untuk gap kegawatdaruratan:

Aktivitas	Penanggung Jawab	Jadwal	Target Selesai
Tutorial prioritas tindakan gawat darurat	Dosen keperawatan gawat darurat	Minggu 1, 2x pertemuan	Hari ke-7
Simulasi kode biru dengan umpan balik	Asesor praktisi	Minggu 2, simulasi 2x	Hari ke-14
Penilaian formatif simulasi kode biru	Asesor praktisi + asesor akademik	Minggu 3, penilaian 1x	Hari ke-21

Pastikan jadwal ini masuk ke kalender akademik prodi dan diinformasikan ke mahasiswa secara tertulis.

Langkah 4: Siapkan Format Bukti Penyelesaian

Pembinaan harus tercatat, bukan sekadar “sudah ikut.” Tentukan sejak awal format bukti yang harus dikumpulkan. Umumnya meliputi:

- Logbook atau jurnal kegiatan pembinaan yang ditandatangani pembimbing.
- Laporan refleksi mahasiswa setelah tiap sesi.
- Lembar penilaian formatif dari asesor.
- Jika ada praktik di klinik, surat keterangan atau presensi dari lahan praktik.

Semua bukti ini nanti disatukan dalam berkas pembinaan mahasiswa dan diarsipkan prodi.

✅ Checklist rencana pembinaan yang siap ditetapkan SK:

- ☐ Peta gap setiap mahasiswa sudah diisi lengkap
- ☐ Bentuk pembinaan sesuai jenis gap
- ☐ Penanggung jawab dan jadwal jelas
- ☐ Format bukti penyelesaian ditentukan
- ☐ Rencana dikonfirmasi ke mahasiswa dan asesor
- ☐ Draft SK penugasan tim pembinaan disiapkan

Langkah 5: Tetapkan dalam SK dan Lakukan Monitoring

Setelah rencana pembinaan disusun, ajukan ke pimpinan perguruan tinggi untuk diterbitkan **SK penugasan tim pembinaan** dan **SK penetapan program penguatan** bagi mahasiswa yang bersangkutan. SK ini menjadi dasar formal pelaksanaan, bukan sekadar instruksi lisan.

Selama pembinaan berjalan, kaprodi atau pengelola RPL melakukan monitoring mingguan: apakah jadwal berjalan? Apakah bukti terkumpul?

Apakah ada hambatan? Catat semua perkembangan dalam berita acara monitoring singkat.

Dengan alur ini, institusi tidak hanya menyiapkan mahasiswa uji kompetensi ulang, tetapi juga menyiapkan diri untuk diaudit atau diminta menjelaskan dasar keputusan akademiknya.

INTI BAB: Ubah hasil asesmen menjadi peta gap yang jelas, lalu rancang pembinaan terstruktur dengan penanggung jawab, jadwal, dan bukti penyelesaian, serta tetapkan melalui SK agar prosesnya tercatat sebagai keputusan institusional.

B A B 8

Simulasi Pelaporan dan Final Review

Ini tahap terakhir sebelum berkas RPL, SK pembinaan, dan laporan resmi keluar dari meja kamu. Bayangkan hari ini ada audit mendadak atau surat klarifikasi dari Kemdiktisaintek. Pertanyaannya: apakah semua dokumen saling cocok, bisa ditelusuri, dan siap dijelaskan dalam 30 menit? Jika belum, bab ini akan memandu kamu menutup satu siklus RPL secara menyeluruh.

Kita pakai satu kasus simulasi singkat: **Mahasiswa D3 Keperawatan, NIM 202201, telah menyelesaikan seluruh teori dan praktik, tetapi belum lulus uji kompetensi. Masa studi tersisa 3 bulan.** Tim kamu sudah menjalankan asesmen RPL, menerbitkan SK hasil asesmen, dan menyusun program pembinaan. Sekarang saatnya melakukan final review.

Langkah Praktik: Pemeriksaan Akhir Secara Berurutan

1. **Cek konsistensi identitas mahasiswa.** Buka file pendaftaran, transkrip, berita acara asesmen, SK hasil, dan rencana pembinaan. Pastikan NIM, nama, prodi, tahun masuk, dan status masa studi tertulis sama persis. Satu perbedaan kecil (misalnya NIM tertukar angka) bisa memicu klarifikasi panjang.
2. **Cocokkan bukti capaian dengan klaim RPL.** Ambil transkrip dan daftar pengalaman praktik. Untuk setiap mata kuliah atau kompetensi yang diklaim, tandai bukti fisiknya: transkrip nilai, logbook praktik, sertifikat pelatihan, atau dokumentasi kegiatan. Jika ada klaim tanpa

bukti, tandai sebagai temuan dan minta klarifikasi ke kaprodi sebelum laporan final.

3. **Periksa berita acara asesmen.** Pastikan asesor yang menandatangani sesuai dengan SK penunjukan tim asesor. Bandingkan skor atau rekomendasi di berita acara dengan draft SK hasil asesmen. Apakah rekomendasi “layak mengikuti pembinaan” konsisten dengan keputusan pembinaan? Jika ada perbedaan, hentikan dulu dan rapatkan dengan pengelola RPL.
4. **Validasi SK hasil asesmen dan SK pembinaan.** Cek nomor surat, tanggal terbit, jabatan penandatangan (dekan atau pimpinan PT), dan lampiran. Pastikan setiap SK mencantumkan dasar hukum yang sama dengan yang dipakai di awal proses RPL. Jangan sampai SK pembinaan terbit sebelum berita acara asesmen selesai.
5. **Telusuri bukti program pembinaan.** Ini bagian paling sering bolong. Cek jadwal pembinaan, daftar hadir, materi, evaluasi singkat, dan rencana uji kompetensi ulang. Bukan sekadar catatan WhatsApp dari kaprodi. Semua harus dalam format institusional: lembar monitoring, berita acara kegiatan, atau laporan unit penjaminan mutu.
6. **Susun paket laporan akhir.** Satukan semua dokumen dalam satu folder digital atau map fisik dengan urutan: data peserta → bukti capaian → berita acara asesmen → SK hasil → rencana dan bukti pembinaan → catatan tindak lanjut. Beri indeks sederhana agar orang lain bisa menemukan dokumen dalam hitungan detik.

✅ Checklist Final Review Sebelum Laporan Dikirim:

- ☐ Nama, NIM, prodi, dan status masa studi konsisten di semua dokumen.
- ☐ Setiap klaim capaian RPL punya bukti transkrip/praktik/logbook.
- ☐ Berita acara asesmen ditandatangani asesor yang sesuai SK.
- ☐ Rekomendasi asesmen sama dengan keputusan di SK hasil.
- ☐ SK hasil dan SK pembinaan punya nomor, tanggal, pejabat berwenang, dan dasar hukum.
- ☐ Program pembinaan punya jadwal, daftar hadir, materi, dan evaluasi.
- ☐ Ada rencana uji kompetensi ulang yang tercatat resmi.
- ☐ Arsip digital tersimpan dalam satu folder dengan penamaan jelas.

Setelah semua checklist tercentang, lakukan **simulasi klarifikasi**. Suruh satu staf atau rekan sejawat berperan sebagai auditor. Minta dia bertanya: “Kenapa mahasiswa ini masuk skema RPL khusus?” atau “Di mana bukti program penguatan kompetensi?” Jika kamu bisa menjawab sambil menunjukkan dokumen dalam waktu kurang dari 2 menit per pertanyaan, berarti arsip dan alur kamu sudah siap.

⛔ Waspada: Jangan pernah menganggap remeh dokumen pembinaan. Banyak institusi gagal klarifikasi bukan karena asesmennya salah, tapi karena program penguatan dan uji ulang tidak terdokumentasi. Akibatnya status mahasiswa menggantung, laporan dipertanyakan, dan penjaminan mutu RPL dinilai lemah.

Latihan terbaik: ambil satu berkas RPL yang sudah hampir selesai, jalankan keenam langkah di atas dari awal sampai akhir. Catat berapa temuan yang

muncul. Perbaiki, lalu simpan versi final. Ulangi sampai temuan nol. Itulah sinyal bahwa institusi kamu siap menutup siklus RPL dengan bersih.

INTI BAB: Final review adalah pemeriksaan konsistensi menyeluruh dari data mahasiswa, bukti capaian, berita acara, SK, dan bukti pembinaan—bukan sekadar memastikan berkas terkirim. Selesaikan tiap tahap dengan checklist, lalu uji kesiapan lewat simulasi klarifikasi agar saat diaudit, semua keputusan bisa dijelaskan dan ditelusuri.